

TEMA 3.24 • OBSTETRICIA

Tratamiento del Síndrome Hipertensivo del Embarazo

PERFIL EUNACOM 2.01.2.018
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Tratamiento del Síndrome Hipertensivo del Embarazo

Antihipertensivos en el Embarazo

Regla general: La mayoría de los AHT están contraindicados en el embarazo (IECA, ARA-II, betabloqueadores, calcio-antagonistas excepto nifedipino LP, etc.)

Fármacos permitidos (vía oral)

TABLA 3.24.1: FÁRMACO VS DETALLE	
FÁRMACO	DETALLE
Alfametildopa	1ª línea — más seguro y con mayor experiencia en embarazo
Labetalol VO	Buena alternativa — buen perfil de seguridad
Nifedipino LP	Opción válida (solo el de liberación prolongada — el de corta es errático)
Hidralacina	Otra opción

Cuándo iniciar AHT

TABLA 3.24.2: FUENTE VS CRITERIO	
FUENTE	CRITERIO
MINSAL	PA ≥ 150/100
Guías internacionales	HTA crónica: ≥ 140/90; HTA gestacional/PE: solo si ≥ 160/110

Crisis Hipertensiva en el Embarazo (PA ≥ 160/110)

Objetivo: Prevenir ACV (no prevenir eclampsia — eso es el MgSO₄).

TABLA 3.24.3: FÁRMACO VS VÍA		
FÁRMACO	VÍA	LUGAR
Labetalol EV	Endovenoso	1ª elección en crisis
Nifedipino	VO	Alternativa si no hay labetalol
Hidralacina	EV	Alternativa

Luego de la crisis → dejar AHT VO para evitar recurrencia.

Manejo de Preeclampsia

Preeclampsia NO severa

TABLA 3.24.4: MEDIDA VS DETALLE	
MEDIDA	DETALLE
Hospitalización	En Chile: habitual; internacionalmente: ambulatoria si fácil acceso
Corticoides antenatales	24–34 semanas (si hay riesgo de parto prematuro)
Monitorización fetal	Doppler semanal, RBNS diario, perfil biofísico c/2–3 días
Exámenes severidad	Semanales
Interrupción	37 semanas (algunos 38 sem)

Preeclampsia SEVERA

TABLA 3.24.5: MEDIDA VS DETALLE	
MEDIDA	DETALLE
Corticoides antenatales	24–34 semanas
AHT	Si PA ≥ 160/110 (labetalol EV crisis; AHT oral mantenimiento)
Sulfato de magnesio	Profilaxis de eclampsia (intraparto y en exaltación neurológica)
Interrupción	Inmediata (o a las 34 sem si feto muy prematuro y condición estable)

Manejo de HTA Crónica en el Embarazo

- Cambiar AHT a **alfametildopa**
- Aspirina 81–100 mg/día (profilaxis PE — es FR de alto riesgo)
- Control en **policlínico de alto riesgo obstétrico** (ambulatorio)
- Seguimiento con proteinuria → si positiviza → sobreagregación PE → manejo como PE

Interrupción: al término (38–40 sem); si requiere AHT: 37 sem; si severa: 34 sem

Manejo de HTA Gestacional

TABLA 3.24.6: SEVERIDAD VS CONDUCTA	
SEVERIDAD	CONDUCTA
Leve (< 160/110)	Observar; controlar proteinuria; descartar PE
Crisis hipertensiva	Manejo igual a PE severa: labetalol EV + interrumpir a las 34–37 sem

Interrupción: 37–40 semanas según control.

Resumen de Interrupción según SHE

TABLA 3.24.7: DIAGNÓSTICO VS MOMENTO DE INTERRUPCIÓN	
DIAGNÓSTICO	MOMENTO DE INTERRUPCIÓN
HTA crónica sin fármacos	38–40 semanas
HTA crónica con AHT	37 semanas
HTA crónica severa	34–37 semanas
PE no severa	37 semanas
PE severa	Inmediata (o 34 sem si estable + prematuro)
HTA gestacional leve	37–40 semanas
HTA gestacional con crisis	34–37 semanas

Vía: Vaginal de regla. En la práctica muchas terminan en cesárea (sufrimiento fetal, necesidad de interrumpir rápidamente).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"En relación a Tratamiento del Síndrome Hipertensivo del Embarazo: Guías internacionales | HTA crónica: $\geq 140/90$; HTA gestacional/PE: solo si ≥ 160 ... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Tratamiento del Síndrome Hipertensivo del Embarazo. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Antihipertensivos en el Embarazo
- Fármacos permitidos (vía oral)
- Cuándo iniciar AHT
- Crisis Hipertensiva en el Embarazo (PA $\geq 160/110$)
- Manejo de Preeclampsia
- Preeclampsia NO severa
- Preeclampsia SEVERA

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRATAMIENTO DEL SÍNDROME HIPERTENSIVO DEL EMBARAZO)**PREGUNTA 1**

En relación a Tratamiento del Síndrome Hipertensivo del Embarazo: Guías internacionales | HTA crónica: $\geq 140/90$; HTA gestacional/PE: solo si ≥ 160 ... ¿cuál es la conducta correcta?

- A)** El diagnóstico de Tratamiento del Síndrome Hipertensivo del Embarazo se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Tratamiento del Síndrome Hipertensivo del Embarazo debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Tratamiento del Síndrome Hipertensivo del Embarazo requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Tratamiento del Síndrome Hipertensivo del Embarazo es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Tratamiento del Síndrome Hipertensivo del Embarazo no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Tratamiento del Síndrome Hipertensivo del Embarazo?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Tratamiento del Síndrome Hipertensivo del Embarazo. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: TRATAMIENTO DEL SÍNDROME HIPERTENSIVO DEL EMBARAZO

Regla general: La mayoría de los AHT están contraindicados en el embarazo (IECA, ARA-II, betabloqueadores, calcio-antagonistas excepto nifedipino LP, etc.) 1. Cambiar AHT a alfametildopa 2. Aspirina 81–100 mg/día (profilaxis PE — es FR de alto riesgo) 3. Control en policlínico de alto riesgo obstétrico (ambulatorio) 4. Seguimiento con proteinuria → si positiviza → sobreagregación PE → manejo como PE Vía: Vaginal de regla. En la práctica muchas terminan en cesárea (sufrimiento fetal, necesidad de interrumpir rápidamente).